GUIA PRÁTICO PARA O CUIDADO DO NEURODESENVOLVIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Instrumento de apoio à vigilância do neurodesenvolvimento e à organização do cuidado de crianças de até 30 meses na Atenção Primária à Saúde.



LARISSA CAVALCANTE
Mestranda do Mestrado Profissional em Saúde da Família – PROFSAÚDE / UFBA

Profa. Dra. Nilia Prado
Orientadora

SALVADOR – BA
2026

SOBRE ESTE GUIA

Este guia foi desenvolvido como produto de mestrado do Programa de Mestrado Profissional em Saúde da Família (PROFSAÚDE), da Universidade Federal da Bahia (UFBA), em 2026.

Seu propósito é apoiar profissionais da Atenção Primária à Saúde no cuidado do neurodesenvolvimento durante a puericultura, organizando aspectos que podem ser observados no acompanhamento da criança e possíveis ações da APS.

O material está organizado em oito domínios: comunicação e linguagem; interação social; cognição, aprendizagem e brincadeira; comportamento; aspectos sensoriais; habilidades adaptativas e autonomia; participação escolar e social; e família e rede de apoio.

A proposta é favorecer um olhar ampliado para desenvolvimento, funcionalidade, participação e contexto, contribuindo para vigilância, acompanhamento longitudinal e coordenação do cuidado.

IMPORTANTE

As faixas etárias apresentadas são referências para a vigilância do desenvolvimento e não constituem pontos de corte diagnósticos. O guia não substitui avaliação clínica individualizada nem avaliação especializada quando indicada.

COMO UTILIZAR ESTE GUIA

Cada domínio é apresentado em uma tabela de consulta rápida. A leitura pode seguir o fluxo abaixo:

1 ASPECTO OBSERVADO	Identifica o comportamento, habilidade, dificuldade ou barreira que merece atenção durante o acompanhamento.
2 FAIXA ETÁRIA DE REFERÊNCIA	Situa a observação no curso do desenvolvimento, sem funcionar como critério diagnóstico isolado.
3 EXEMPLOS DE OBSERVAÇÃO	Traduz o aspecto em situações que podem ser percebidas na consulta, pela família ou em outros contextos da criança.
4 POSSÍVEIS AÇÕES DA APS	Apresenta possibilidades de avaliação, orientação, acompanhamento, coordenação do cuidado e articulação da rede.
5 REFERÊNCIAS MS ÚTEIS	Indica os documentos do Ministério da Saúde que fundamentam ou complementam aquele conteúdo.

Uso sugerido: o guia pode ser consultado durante a puericultura, na discussão de casos e no planejamento do cuidado. A interpretação deve considerar história clínica, trajetória do desenvolvimento, contexto familiar e social e necessidades singulares da criança.

VIGILÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO

Um apoio para interpretar as faixas etárias apresentadas neste guia

IMPORTANTE

As faixas etárias deste guia são referências para a vigilância do desenvolvimento e não constituem pontos de corte diagnósticos. A avaliação deve considerar a trajetória da criança, a observação clínica, as informações da família e os instrumentos oficiais de acompanhamento.

Marcos do desenvolvimento na puericultura

A Caderneta da Criança é o instrumento oficial do Ministério da Saúde para acompanhar saúde, crescimento e desenvolvimento. Na parte destinada aos profissionais, reúne instrumentos de vigilância do desenvolvimento; a versão digital também apresenta marcos do desenvolvimento e alertas de atenção.

- Consulte os marcos esperados para a faixa etária durante o acompanhamento longitudinal.
- Interprete cada achado em conjunto com os demais domínios do desenvolvimento e com o contexto da criança.
- Diante de atraso, perda de habilidades ou outros sinais de alerta, amplie a avaliação e organize o seguimento conforme a necessidade.

CONSULTE OS MARCOS DO DESENVOLVIMENTO

Aponte a câmera do celular para acessar a página oficial da Caderneta da Criança - Ministério da Saúde.

OS 8 DOMÍNIOS DO GUIA

O cuidado do neurodesenvolvimento na APS requer um olhar ampliado para as habilidades da criança, sua funcionalidade, participação e contexto de vida. Para facilitar a observação durante a puericultura e a organização do cuidado, este guia está estruturado em oito domínios complementares.

01 Comunicação e linguagem

Comunicação verbal e não verbal, intenção comunicativa, gestos, imitação e atenção compartilhada.

02 Interação social

Iniciativa, resposta, reciprocidade e participação nas interações e brincadeiras compartilhadas.

03 Cognição, aprendizagem e brincadeira

Imitação funcional, compreensão, aprendizagem, generalização de habilidades e brincadeira simbólica.

04 Comportamental

Padrões repetitivos, interesses restritos e flexibilidade diante de mudanças.

05 Sensorial

Respostas aos estímulos sensoriais e possíveis repercussões nas atividades cotidianas, higiene e alimentação.

06 Habilidades adaptativas e autonomia

Atividades de vida diária, organização das rotinas, autonomia e desempenho motor.

07 Escolar e participação Social

Participação nos ambientes educacionais e coletivos, considerando barreiras, acessibilidade e necessidades de apoio.

08 Familiar e rede de apoio

Necessidades dos cuidadores, continuidade do cuidado, vulnerabilidades sociais, direitos e rede de apoio.

OLHAR INTEGRADO

Os domínios não devem ser avaliados isoladamente. O desenvolvimento infantil é integrado, e uma mesma situação pode envolver diferentes áreas. A organização em domínios tem

finalidade prática: apoiar a observação, o acompanhamento longitudinal e o planejamento do cuidado na APS.

No Domínio 4, situações de desregulação comportamental são apresentadas separadamente como situações associadas que merecem atenção na APS.

1. Comunicação e linguagem

Foco: comunicação verbal e não verbal, uso funcional da comunicação, imitação comunicativa, regressão e atenção compartilhada.

Aspecto observado	Faixa etária de referência	Exemplos de observação	Possíveis ações da APS	Referências MS úteis
Resposta reduzida ou ausente ao nome	6–12 meses: observar o desenvolvimento progressivo da resposta ao ser chamado pelo nome.	Parece ignorar quando chamado; responde de forma inconsistente ou apenas após repetição, aproximação ou toque.	Avaliar desenvolvimento global e demais sinais sociocomunicativos; observar resposta a outros sons; considerar avaliação auditiva quando indicada; acompanhar longitudinalmente.	Linha de Cuidado para Pessoas com TEA (MS, 2025); Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com TEA (MS, 2014); Diretrizes de Estimulação Precoce (MS, 2016). Guia sobre a Estimulação Precoce na Atenção Básica (MS, 2016); Desenvolvimento Neuropsicomotor, Sinais de Alerta e Estimulação Precoce (MS, 2023).

Aspecto observado	Faixa etária de referência	Exemplos de observação	Possíveis ações da APS	Referências MS úteis
Atraso na aquisição da linguagem oral	12–18 meses: observar surgimento e progressão das primeiras palavras. 18–24 meses: observar ampliação do vocabulário e progressão para combinações de palavras.	Poucas palavras para a idade; ausência de progressão do vocabulário; ausência ou atraso na combinação de palavras.	Avaliar desenvolvimento global e linguagem receptiva e expressiva; investigar audição quando indicado; orientar oportunidades de comunicação nas atividades cotidianas; acompanhar evolução e articular avaliação/intervenção especializada quando necessária.	Linha de Cuidado para Pessoas com TEA (MS, 2025); Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com TEA (MS, 2014); Diretrizes de Estimulação Precoce (MS, 2016). Guia sobre a Estimulação Precoce na Atenção Básica (MS, 2016); Desenvolvimento Neuropsicomotor, Sinais de Alerta e Estimulação Precoce (MS, 2023).

Aspecto observado	Faixa etária de referência	Exemplos de observação	Possíveis ações da APS	Referências MS úteis
Dificuldade no uso funcional da comunicação	Desde o período pré-linguístico, observando progressivamente o uso de recursos não verbais e verbais para comunicar necessidades, escolhas e intenções.	Dificuldade para pedir ajuda, solicitar algo, recusar, escolher ou expressar necessidades, verbalmente ou por outros meios comunicativos.	Identificar como a criança já se comunica; orientar família a reconhecer e responder às iniciativas comunicativas; ampliar oportunidades de escolha e expressão nas rotinas; articular avaliação especializada quando houver necessidade de recursos específicos de comunicação.	Linha de Cuidado para Pessoas com TEA (MS, 2025); Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com TEA (MS, 2014); Desenvolvimento Neuropsicomotor, Sinais de Alerta e Estimulação Precoce (MS, 2023).

Aspecto observado	Faixa etária de referência	Exemplos de observação	Possíveis ações da APS	Referências MS úteis
Uso reduzido de gestos comunicativos	9–12 meses: observar surgimento de gestos a partir de modelos. 12–18 meses: observar ampliação do repertório gestual, incluindo apontar. 18–24 meses: espera-se utilização mais ampla de gestos na comunicação.	Pouco uso de apontar, acenar, bater palmas, mandar beijo, mostrar ou utilizar movimentos de cabeça para comunicar.	Observar gestos no contexto da interação; orientar brincadeiras e rotinas que favoreçam comunicação gestual; valorizar e responder às diferentes formas de comunicação utilizadas pela criança; acompanhar progressão.	Diretrizes de Estimulação Precoce (MS, 2016); Linha de Cuidado para Pessoas com TEA (MS, 2025). Guia sobre a Estimulação Precoce na Atenção Básica (MS, 2016); Desenvolvimento Neuropsicomotor, Sinais de Alerta e Estimulação Precoce (MS, 2023).
Imitação vocal e gestual reduzida	6–12 meses: observar surgimento da imitação de gestos e sons. Ao longo do segundo ano: observar ampliação progressiva do repertório imitativo.	Pouco imita sons, vocalizações ou gestos como acenar, bater palmas, mandar beijo ou outros movimentos observados.	Favorecer brincadeiras interativas e oportunidades naturais de imitação; utilizar modelos simples durante as rotinas; acompanhar progressão e demais aspectos do desenvolvimento e da comunicação.	Diretrizes de Estimulação Precoce (MS, 2016). Guia sobre a Estimulação Precoce na Atenção Básica (MS, 2016); Desenvolvimento Neuropsicomotor, Sinais de Alerta e Estimulação Precoce (MS, 2023).

Aspecto observado	Faixa etária de referência	Exemplos de observação	Possíveis ações da APS	Referências MS úteis
Perda de habilidades previamente adquiridas (regressão do desenvolvimento)	Em qualquer idade: perda de habilidade previamente adquirida constitui sinal de alerta e requer avaliação.	Deixa de utilizar palavras, gestos ou outras habilidades comunicativas que anteriormente estavam presentes.	Caracterizar habilidade perdida, momento de início e outros domínios envolvidos; realizar avaliação clínica e do desenvolvimento; avaliar audição/visão e outros sinais conforme o quadro; encaminhar quando indicado e iniciar intervenções pertinentes sem aguardar conclusão diagnóstica.	Linha de Cuidado para Pessoas com TEA (MS, 2025); Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com TEA (MS, 2014); Diretrizes de Estimulação Precoce (MS, 2016). Guia sobre a Estimulação Precoce na Atenção Básica (MS, 2016); Desenvolvimento Neuropsicomotor, Sinais de Alerta e Estimulação Precoce (MS, 2023).

Aspecto observado	Faixa etária de referência	Exemplos de observação	Possíveis ações da APS	Referências MS úteis
Dificuldade em iniciar ou responder à atenção compartilhada	9–12 meses: observar emergência de comportamentos de atenção compartilhada. 12–18 meses: observar sua ampliação e maior integração à comunicação.	Pouco alterna o olhar entre pessoa e objeto; não acompanha facilmente olhar ou apontar do outro; pouco aponta, mostra ou leva objetos para compartilhar interesse.	Observar atenção compartilhada em situações naturais; orientar interações face a face, brincadeiras e atividades compartilhadas; acompanhar sua evolução juntamente com outros aspectos sociocomunicativos.	Linha de Cuidado para Pessoas com TEA (MS, 2025); Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com TEA (MS, 2014); Diretrizes de Estimulação Precoce (MS, 2016). Guia sobre a Estimulação Precoce na Atenção Básica (MS, 2016); Desenvolvimento Neuropsicomotor, Sinais de Alerta e Estimulação Precoce (MS, 2023).

2. Interação social

Foco: iniciativa, resposta e reciprocidade nas trocas sociais. Atenção compartilhada permanece no Domínio 1.

Aspecto observado	Faixa etária de referência	Exemplos de observação	Possíveis ações da APS	Referências MS úteis
Uso reduzido do olhar para iniciar ou manter a interação social	Ao longo do desenvolvimento, considerando a integração progressiva do olhar com gestos, expressões e outras formas de comunicação social.	Utiliza pouco o olhar para iniciar, responder ou sustentar uma interação; pouca coordenação entre olhar e outros recursos comunicativos.	Observar o uso do olhar no contexto das interações, integrado a gestos, expressões e comunicação; orientar interações responsivas e brincadeiras compartilhadas; acompanhar outros aspectos sociocomunicativos. Não orientar contato ocular forçado.	Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com TEA (MS, 2014); Linha de Cuidado para Pessoas com TEA (MS, 2025); Desenvolvimento Neuropsicomotor, Sinais de Alerta e Estimulação Precoce (MS, 2023).

Aspecto observado	Faixa etária de referência	Exemplos de observação	Possíveis ações da APS	Referências MS úteis
Reciprocidade social reduzida	Ao longo do desenvolvimento: observar progressivamente iniciativa, resposta e manutenção das trocas sociais, de acordo com a idade e o nível de desenvolvimento.	Pouca iniciativa ou resposta às aproximações sociais; dificuldade para manter trocas de ida e volta; interação pouco recíproca.	Observar iniciativa, resposta e continuidade das interações em diferentes contextos; orientar cuidadores a reconhecer e responder às iniciativas da criança; favorecer oportunidades naturais de interação e acompanhar evolução.	Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com TEA (MS, 2014); Linha de Cuidado para Pessoas com TEA (MS, 2025); Desenvolvimento Neuropsicomotor, Sinais de Alerta e Estimulação Precoce (MS, 2023).
Interesse e interação reduzidos com outras crianças	Especialmente a partir da ampliação das oportunidades de convivência com pares, considerando idade, desenvolvimento e contexto.	Pouca iniciativa para aproximar-se de outras crianças; responde pouco às tentativas de interação; dificuldade para iniciar ou manter interação com pares.	Investigar interesse, iniciativa e resposta às interações com pares em diferentes contextos; orientar oportunidades graduais e significativas de convivência e interação, respeitando as necessidades e formas de participação da criança.	Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com TEA (MS, 2014); Linha de Cuidado para Pessoas com TEA (MS, 2025); Desenvolvimento Neuropsicomotor, Sinais de Alerta e Estimulação Precoce (MS, 2023).

Aspecto observado	Faixa etária de referência	Exemplos de observação	Possíveis ações da APS	Referências MS úteis
Dificuldade em participar de brincadeiras compartilhadas	Ao longo do desenvolvimento da brincadeira social, considerando idade, habilidades adquiridas e oportunidades de interação.	Tende a brincar de forma predominantemente individual; dificuldade para participar de brincadeiras com outra pessoa, compartilhar a atividade ou sustentar trocas durante o brincar.	Observar como a criança participa das brincadeiras; orientar cuidadores a entrar nos interesses e atividades da criança e criar oportunidades de brincadeira conjunta; utilizar demonstração e mediação quando úteis, respeitando sinais de interesse e desconforto.	Diretrizes de Estimulação Precoce (MS, 2016); Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com TEA (MS, 2014); Linha de Cuidado para Pessoas com TEA (MS, 2025). Guia sobre a Estimulação Precoce na Atenção Básica (MS, 2016); Desenvolvimento Neuropsicomotor, Sinais de Alerta e Estimulação Precoce (MS, 2023).

Aspecto observado	Faixa etária de referência	Exemplos de observação	Possíveis ações da APS	Referências MS úteis
Expressões faciais e afetivas pouco integradas à interação social	Ao longo do desenvolvimento: observar a integração progressiva entre expressões faciais, gestos, vocalizações/fala e contexto social.	Expressões faciais ou afetivas pouco coordenadas com a interação; pouca variação ou integração entre expressão, gesto, olhar e comunicação durante as trocas sociais.	Observar a comunicação não verbal como um conjunto, considerando contexto e formas individuais de expressão; orientar interações responsivas e acompanhar conjuntamente os demais aspectos da comunicação e interação social.	Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com TEA (MS, 2014); Linha de Cuidado para Pessoas com TEA (MS, 2025); Desenvolvimento Neuropsicomotor, Sinais de Alerta e Estimulação Precoce (MS, 2023).

3. Cognição, aprendizagem e brincadeira

Foco: imitação funcional, compreensão, generalização da aprendizagem e brincadeira simbólica.

Aspecto observado	Faixa etária de referência	Exemplos de observação	Possíveis ações da APS	Referências MS úteis
Imitação funcional reduzida	Ao longo do desenvolvimento, especialmente a partir do segundo ano de vida: observar a capacidade de reproduzir ações demonstradas e utilizar objetos funcionalmente, considerando idade e desenvolvimento.	Pouco reproduz ações observadas, como pentear o cabelo, empurrar um carrinho ou realizar ações simples com objetos após demonstração.	Observar a imitação em brincadeiras e atividades cotidianas; orientar cuidadores a demonstrar ações simples e oferecer oportunidades naturais para reproduzi-las; acompanhar progressão e repercussões na aprendizagem.	Diretrizes de Estimulação Precoce (MS, 2016). Guia sobre a Estimulação Precoce na Atenção Básica (MS, 2016); Desenvolvimento Neuropsicomotor, Sinais de Alerta e Estimulação Precoce (MS, 2023).

Aspecto observado	Faixa etária de referência	Exemplos de observação	Possíveis ações da APS	Referências MS úteis
Dificuldade em compreender e executar instruções simples	18–24 meses: observar compreensão de frases e instruções simples associadas ao contexto. A partir de 24 meses: observar progressão para instruções envolvendo mais elementos, conforme o desenvolvimento.	Parece não compreender solicitações simples; necessita repetição, gestos ou demonstração frequentes; apresenta dificuldade crescente conforme aumenta a complexidade da instrução.	Avaliar compreensão no contexto cotidiano e considerar linguagem receptiva, atenção e desenvolvimento global; utilizar instruções claras e compatíveis com o nível de desenvolvimento, associando gestos ou demonstração quando úteis; acompanhar progressão.	Diretrizes de Estimulação Precoce (MS, 2016); Linha de Cuidado para Pessoas com TEA (MS, 2025). Guia sobre a Estimulação Precoce na Atenção Básica (MS, 2016); Desenvolvimento Neuropsicomotor, Sinais de Alerta e Estimulação Precoce (MS, 2023).
Dificuldade de generalização de habilidades aprendidas	Ao longo do desenvolvimento e da aquisição de novas habilidades: observar se aprendizagens adquiridas são utilizadas em diferentes pessoas, ambientes e situações.	Realiza determinada habilidade em uma situação, mas apresenta dificuldade para utilizá-la em outro ambiente, com outra pessoa ou diante de materiais diferentes.	Identificar em quais contextos a habilidade já ocorre; orientar oportunidades de utilização da habilidade em diferentes situações cotidianas, pessoas e ambientes; acompanhar necessidade de apoio e progressão.	Linha de Cuidado para Pessoas com TEA (MS, 2025).

Aspecto observado	Faixa etária de referência	Exemplos de observação	Possíveis ações da APS	Referências MS úteis
Brincadeira simbólica reduzida	18–24 meses: observar surgimento de brincadeiras simbólicas simples. 30–36 meses: observar ampliação do faz-de-conta e imitação de papéis sociais.	Pouco realiza brincadeiras de faz-de-conta, como alimentar uma boneca, fingir preparar comida ou representar situações e papéis cotidianos; pode utilizar os objetos predominantemente de forma concreta ou repetitiva.	Observar brincadeira espontânea e após demonstração; orientar cuidadores a participar das brincadeiras e oferecer modelos simples de faz-de-conta, acompanhando os interesses e o nível de desenvolvimento da criança; acompanhar evolução.	Diretrizes de Estimulação Precoce (MS, 2016); Linha de Cuidado para Pessoas com TEA (MS, 2025). Guia sobre a Estimulação Precoce na Atenção Básica (MS, 2016); Desenvolvimento Neuropsicomotor, Sinais de Alerta e Estimulação Precoce (MS, 2023).

4. Comportamental: padrões restritos e repetitivos

Os três itens abaixo correspondem ao núcleo deste domínio. A desregulação comportamental é apresentada separadamente como problema associado.

Aspecto observado	Faixa etária de referência	Exemplos de observação	Possíveis ações da APS	Referências MS úteis
Movimentos motores repetitivos ou estereotipados	Ao longo do desenvolvimento: observar presença, frequência, intensidade, contexto e eventual repercussão funcional dos movimentos repetitivos.	Balançar o corpo; movimentos repetitivos das mãos; girar o corpo; outros movimentos motores repetitivos ou estereotipados.	Caracterizar os movimentos e os contextos em que ocorrem; avaliar repercussões sobre segurança, atividades cotidianas, interação e participação; orientar a família e acompanhar longitudinalmente. Evitar intervenções voltadas apenas à supressão do comportamento quando não houver sofrimento, risco ou prejuízo funcional relevante.	Linha de Cuidado para Pessoas com TEA (MS, 2025); Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com TEA (MS, 2014); Desenvolvimento Neuropsicomotor, Sinais de Alerta e Estimulação Precoce (MS, 2023).

Aspecto observado	Faixa etária de referência	Exemplos de observação	Possíveis ações da APS	Referências MS úteis
Inflexibilidade diante de mudanças, rotinas e transições	Ao longo do desenvolvimento: observar respostas a mudanças nas atividades, sequências, ambientes e rotinas, considerando idade, desenvolvimento e contexto.	Sofrimento ou resistência diante de alterações na rotina; dificuldade para interromper uma atividade e iniciar outra; necessidade acentuada de manter determinadas sequências ou formas de realizar atividades.	Identificar situações e mudanças que desencadeiam maior dificuldade; favorecer previsibilidade e antecipação de mudanças e transições; utilizar sequências ou apoios visuais quando úteis; orientar estratégias individualizadas e acompanhar a repercussão funcional.	Linha de Cuidado para Pessoas com TEA (MS, 2025); Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com TEA (MS, 2014); Desenvolvimento Neuropsicomotor, Sinais de Alerta e Estimulação Precoce (MS, 2023).

Aspecto observado	Faixa etária de referência	Exemplos de observação	Possíveis ações da APS	Referências MS úteis
Interesses restritos ou intensos	Ao longo do desenvolvimento: observar intensidade, variedade, persistência e repercussão dos interesses nas atividades cotidianas e na participação.	Interesse muito intenso ou persistente por determinado objeto, parte de objeto, atividade ou tema; busca repetida pelo mesmo interesse; grande atração por movimentos previsíveis, como rodas ou objetos que giram.	Identificar interesses e sua repercussão funcional; valorizá-los como possíveis oportunidades de interação e aprendizagem; favorecer ampliação gradual do repertório quando a restrição estiver interferindo significativamente nas atividades ou participação.	Linha de Cuidado para Pessoas com TEA (MS, 2025); Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com TEA (MS, 2014); Desenvolvimento Neuropsicomotor, Sinais de Alerta e Estimulação Precoce (MS, 2023).

SITUAÇÃO ASSOCIADA QUE MERECE ATENÇÃO NA APS

Atenção: episódios de desregulação comportamental não devem ser automaticamente atribuídos ao TEA. Mudanças no comportamento podem estar relacionadas a dor, doença, dificuldades de comunicação, alterações do sono, mudanças de rotina, fatores sensoriais ou ambientais, entre outras condições, e devem ser avaliadas de forma contextualizada.

Aspecto observado	Faixa etária de referência	Exemplos de observação	Possíveis ações da APS	Referências MS úteis
Episódios de desregulação comportamental	Ao longo do desenvolvimento: diante de episódios recorrentes ou mudança do padrão habitual, caracterizar frequência, duração, intensidade, contexto, possíveis desencadeantes e repercussão funcional.	Choro intenso, gritos, agitação ou, conforme a apresentação, agressão ou autoagressão; episódios relacionados a mudanças, sobrecarga ou outras situações desencadeantes.	Investigar possíveis fatores associados, incluindo dor ou doença, dificuldades de comunicação, sono, mudanças de rotina e fatores sensoriais/ambientais; identificar desencadeantes e estratégias que auxiliam a regulação; orientar adaptações individualizadas; avaliar risco e necessidade de cuidado especializado quando os episódios forem frequentes, intensos ou comprometerem a segurança.	Linha de Cuidado para Pessoas com TEA (MS, 2025).

5. Sensorial

Os três primeiros itens descrevem características sensoriais. Higiene e seletividade alimentar são possíveis repercussões funcionais associadas e não devem ser automaticamente atribuídas a alterações sensoriais.

Aspecto observado	Faixa etária de referência	Exemplos de observação	Possíveis ações da APS	Referências MS úteis
Hiper-reatividade a sons	Ao longo do desenvolvimento: observar respostas intensas, persistentes ou incomuns a sons cotidianos, considerando contexto e repercussão funcional.	Cobre os ouvidos, afasta-se, chora ou demonstra desconforto intenso diante de determinados sons cotidianos.	Identificar sons e situações associados às respostas e sua repercussão nas atividades e participação; orientar adaptações ambientais individualizadas; considerar avaliação auditiva quando houver dúvida sobre a audição; articular cuidado especializado quando houver repercussão funcional importante.	Linha de Cuidado para Pessoas com TEA (MS, 2025); Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com TEA (MS, 2014); Desenvolvimento Neuropsicomotor, Sinais de Alerta e Estimulação Precoce (MS, 2023).

Aspecto observado	Faixa etária de referência	Exemplos de observação	Possíveis ações da APS	Referências MS úteis
Hiper-reatividade tátil	Ao longo do desenvolvimento: observar respostas intensas, persistentes ou incomuns ao toque e a determinadas texturas, considerando contexto e repercussão funcional.	Desconforto ou recusa diante de determinados toques, roupas, materiais ou texturas; dificuldade em atividades de cuidado pessoal envolvendo contato corporal.	Identificar estímulos e contextos associados e repercussões nas atividades cotidianas; investigar dor, alterações de pele, problemas odontológicos ou outras condições clínicas quando pertinentes; antecipar procedimentos e adaptar ambiente e rotina; favorecer participação gradual, respeitando os sinais da criança; articular cuidado especializado quando necessário.	Linha de Cuidado para Pessoas com TEA (MS, 2025); Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com TEA (MS, 2014); Desenvolvimento Neuropsicomotor, Sinais de Alerta e Estimulação Precoce (MS, 2023).

Aspecto observado	Faixa etária de referência	Exemplos de observação	Possíveis ações da APS	Referências MS úteis
Hipo-reatividade ou busca sensorial aumentada	Ao longo do desenvolvimento: observar respostas reduzidas a determinados estímulos ou busca intensa/repetitiva por experiências sensoriais, considerando modalidade, contexto e repercussão funcional.	Parece responder pouco a determinados estímulos; toca ou cheira objetos repetidamente; busca estímulos visuais repetitivos ou movimentação corporal intensa.	Identificar modalidade sensorial, frequência, contexto, repercussão funcional e possíveis riscos; orientar adaptações que favoreçam segurança e participação; acompanhar longitudinalmente e articular reabilitação quando houver necessidade funcional relevante.	Linha de Cuidado para Pessoas com TEA (MS, 2025); Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com TEA (MS, 2014); Desenvolvimento Neuropsicomotor, Sinais de Alerta e Estimulação Precoce (MS, 2023).

Aspecto observado	Faixa etária de referência	Exemplos de observação	Possíveis ações da APS	Referências MS úteis
Dificuldades nos cuidados pessoais e higiene	Ao longo do desenvolvimento: considerar idade, nível de desenvolvimento, autonomia esperada e repercussão nas atividades cotidianas.	Dificuldade ou recusa durante banho, lavagem ou corte dos cabelos, corte das unhas, troca de roupas ou escovação dos dentes; pode apresentar afastamento, choro ou agitação durante determinadas atividades.	Identificar quais cuidados apresentam dificuldade e possíveis fatores sensoriais, comunicacionais, ambientais ou relacionados à previsibilidade; investigar dor e condições clínicas, inclusive de saúde bucal; antecipar etapas e organizar rotina previsível; realizar adaptações individualizadas e favorecer participação gradual; articular Saúde Bucal, reabilitação ou outros profissionais conforme a necessidade.	Linha de Cuidado para Pessoas com TEA (MS, 2025); Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com TEA (MS, 2014); Desenvolvimento Neuropsicomotor, Sinais de Alerta e Estimulação Precoce (MS, 2023).

Aspecto observado	Faixa etária de referência	Exemplos de observação	Possíveis ações da APS	Referências MS úteis
Seletividade alimentar	Ao longo do desenvolvimento: observar restrição persistente ou importante da variedade alimentar, considerando repertório de alimentos aceitos, grupos alimentares excluídos e repercussões nutricionais, no crescimento e na rotina familiar.	Aceita repertório muito restrito; recusa determinadas texturas, sabores, cheiros, temperaturas ou apresentações; exclui determinados alimentos ou grupos alimentares.	Avaliar repertório e rotina alimentar, crescimento e possíveis fatores sensoriais, oromotores ou clínicos associados; orientar ampliação gradual e não coercitiva da variedade alimentar; articular cuidado multiprofissional diante de repercussão nutricional ou funcional.	Linha de Cuidado para Pessoas com TEA (MS, 2025); Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos (MS, 2019), quando aplicável à faixa etária; Desenvolvimento Neuropsicomotor, Sinais de Alerta e Estimulação Precoce (MS, 2023).

6. Habilidades adaptativas e autonomia

Foco: funcionalidade, participação nas atividades cotidianas e nível de apoio necessário.

Aspecto observado	Faixa etária de referência	Exemplos de observação	Possíveis ações da APS	Referências MS úteis
Dificuldades nas atividades de vida diária	Ao longo do desenvolvimento: observar participação e grau de independência nas atividades cotidianas, considerando idade, nível de desenvolvimento e oportunidades prévias de aprendizagem.	Necessita ajuda maior que a esperada para idade/desenvolvimento para alimentar-se, vestir-se, realizar higiene, usar o banheiro, guardar objetos ou realizar outras tarefas cotidianas.	Identificar habilidades já adquiridas, barreiras e nível de apoio necessário; pactuar com a família pequenas metas funcionais; orientar prática nas rotinas cotidianas, dividindo atividades em etapas e utilizando demonstração, pistas ou outros apoios quando úteis; acompanhar progressos e ajustar o nível de ajuda conforme a resposta da criança; articular reabilitação quando necessário.	Diretrizes de Estimulação Precoce (MS, 2016); Linha de Cuidado para Pessoas com TEA (MS, 2025). Guia sobre a Estimulação Precoce na Atenção Básica (MS, 2016); Desenvolvimento Neuropsicomotor, Sinais de Alerta e Estimulação Precoce (MS, 2023).

Aspecto observado	Faixa etária de referência	Exemplos de observação	Possíveis ações da APS	Referências MS úteis
Dificuldade na organização e realização de rotinas	Ao longo do desenvolvimento: observar a capacidade de participar e realizar sequências de atividades cotidianas, considerando idade, nível de desenvolvimento e apoio necessário.	Dificuldade para iniciar, seguir ou concluir as etapas de uma atividade; necessita de ajuda frequente para saber o que fazer em seguida durante tarefas como vestir-se, organizar materiais ou realizar higiene.	Identificar atividades e etapas em que há maior necessidade de apoio; organizar sequências simples e previsíveis; utilizar pistas verbais, gestuais, visuais ou demonstração quando úteis; favorecer prática nas situações cotidianas e acompanhar progressivamente o nível de apoio necessário.	Diretrizes de Estimulação Precoce (MS, 2016); Linha de Cuidado para Pessoas com TEA (MS, 2025). Guia sobre a Estimulação Precoce na Atenção Básica (MS, 2016); Desenvolvimento Neuropsicomotor, Sinais de Alerta e Estimulação Precoce (MS, 2023).

Aspecto observado	Faixa etária de referência	Exemplos de observação	Possíveis ações da APS	Referências MS úteis
Alterações do desenvolvimento e desempenho motor	Conforme a faixa etária: observar aquisição e progressão das habilidades motoras, considerando os marcos do desenvolvimento e o desempenho nas atividades cotidianas.	Atraso na aquisição de habilidades motoras; dificuldades de equilíbrio, coordenação motora grossa ou fina; alterações que interferem no brincar, mobilidade, autocuidado ou outras atividades cotidianas.	Realizar vigilância do desenvolvimento e avaliação clínica; identificar repercussões funcionais no brincar, mobilidade, autocuidado e participação; favorecer oportunidades adequadas de movimento e exploração; investigar outras condições quando indicado e articular reabilitação conforme a necessidade.	Diretrizes de Estimulação Precoce (MS, 2016). Guia sobre a Estimulação Precoce na Atenção Básica (MS, 2016); Desenvolvimento Neuropsicomotor, Sinais de Alerta e Estimulação Precoce (MS, 2023).

Nota prática: ao avaliar atividades de vida diária, registrar o nível de apoio necessário: realiza sozinha; necessita supervisão; ajuda parcial; ou ajuda total.

7. Escolar e participação social

Foco: participação, barreiras e apoios nos contextos coletivos, evitando repetir características sociocomunicativas já descritas no Domínio 2.

Aspecto observado	Faixa etária de referência	Exemplos de observação	Possíveis ações da APS	Referências MS úteis
Dificuldades de participação e adaptação ao ambiente escolar	A partir da inserção no ambiente educacional: observar participação nas atividades e rotinas escolares, considerando idade, desenvolvimento, necessidades de apoio e características do ambiente.	Dificuldade para participar das rotinas ou atividades escolares; necessidade de apoio para acompanhar determinadas propostas; dificuldades nas transições entre atividades ou ambientes; participação prejudicada por barreiras ambientais, comunicacionais ou organizacionais.	Identificar, junto à criança, família e escola, situações que facilitam ou dificultam a participação; reconhecer necessidades de apoio e possíveis barreiras; compartilhar estratégias que favoreçam a participação e continuidade do cuidado; articular saúde, família, escola e demais pontos da rede quando necessário.	Linha de Cuidado para Pessoas com TEA (MS, 2025). Guia sobre a Estimulação Precoce na Atenção Básica (MS, 2016); Desenvolvimento Neuropsicomotor, Sinais de Alerta e Estimulação Precoce (MS, 2023).

Aspecto observado	Faixa etária de referência	Exemplos de observação	Possíveis ações da APS	Referências MS úteis
Barreiras à participação social em contextos coletivos	Ao longo do desenvolvimento, especialmente com a ampliação das oportunidades de convivência em contextos coletivos: observar participação considerando interesse da criança, características do ambiente e apoios disponíveis.	Participa pouco de atividades coletivas; permanece à margem de brincadeiras ou atividades mesmo demonstrando interesse; encontra dificuldades relacionadas às características do ambiente, da atividade, da comunicação ou aos apoios disponíveis.	Identificar interesses, formas de participação, barreiras e facilitadores nos diferentes contextos; valorizar modos diversos de interação e participação; discutir adaptações e apoios possíveis com família, e rede, respeitando necessidades e características da criança.	Linha de Cuidado para Pessoas com TEA (MS, 2025). Guia sobre a Estimulação Precoce na Atenção Básica (MS, 2016); Desenvolvimento Neuropsicomotor, Sinais de Alerta e Estimulação Precoce (MS, 2023).

Aspecto observado	Faixa etária de referência	Exemplos de observação	Possíveis ações da APS	Referências MS úteis
Barreiras de comunicação e acessibilidade no ambiente escolar	A partir da inserção no ambiente educacional: observar se as formas de comunicação utilizadas pela criança são compreendidas e apoiadas e se existem barreiras à comunicação no ambiente.	Dificuldade para expressar necessidades, escolhas ou solicitar ajuda no contexto escolar; instruções pouco acessíveis; ausência ou insuficiência de estratégias ou recursos de comunicação necessários à participação.	Identificar, junto à família e à escola/creche, as formas de comunicação utilizadas pela criança e possíveis barreiras; compartilhar estratégias já efetivas; favorecer acessibilidade comunicacional e articular avaliação especializada quando houver necessidade de recursos específicos de comunicação.	Linha de Cuidado para Pessoas com TEA (MS, 2025); Desenvolvimento Neuropsicomotor, Sinais de Alerta e Estimulação Precoce (MS, 2023).

Nota: a atuação da APS no contexto escolar não substitui a avaliação pedagógica. Cabe à APS identificar necessidades relacionadas à saúde e à funcionalidade, reconhecer barreiras à participação, apoiar a família e articular o cuidado com a escola e a rede intersetorial.

8. Familiar e rede de apoio

Foco: necessidades da família/cuidadores, continuidade do cuidado, condições sociais e recursos formais e informais de apoio.

Aspecto observado	Faixa etária de referência	Exemplos de observação	Possíveis ações da APS	Referências MS úteis
Necessidades e sobrecarga do cuidador/família	Ao longo do acompanhamento: observar necessidades de apoio da família/cuidadores e possíveis repercussões do cuidado sobre saúde, bem-estar e organização da vida cotidiana.	Cansaço; dificuldade para conciliar cuidado, sono, trabalho e autocuidado; responsabilidades concentradas em uma pessoa; dificuldade do cuidador para cuidar da própria saúde.	Realizar escuta qualificada; identificar necessidades e repercussões do cuidado; avaliar possibilidades de compartilhamento das responsabilidades; orientar estratégias factíveis de cuidado e autocuidado; articular recursos da rede conforme as necessidades identificadas.	Linha de Cuidado para Pessoas com TEA (MS, 2025). Guia sobre a Estimulação Precoce na Atenção Básica (MS, 2016); Desenvolvimento Neuropsicomotor, Sinais de Alerta e Estimulação Precoce (MS, 2023).

Aspecto observado	Faixa etária de referência	Exemplos de observação	Possíveis ações da APS	Referências MS úteis
Barreiras ao acesso e à continuidade do cuidado	Ao longo do acompanhamento: identificar fatores que dificultem acesso aos serviços, continuidade do acompanhamento ou realização do plano de cuidado pactuado.	Dificuldade de transporte ou horários; interrupção de acompanhamentos; dificuldade de acesso aos serviços necessários; múltiplas demandas familiares; dificuldade para compreender ou realizar parte do plano de cuidado.	Investigar as barreiras junto à família; revisar prioridades e pactuar plano factível conforme necessidades, possibilidades e preferências; coordenar o cuidado e qualificar encaminhamentos; articular os diferentes pontos da rede e acompanhar a continuidade do cuidado.	Linha de Cuidado para Pessoas com TEA (MS, 2025).
Vulnerabilidades sociais e acesso a direitos	Ao longo do acompanhamento: identificar condições sociais que possam repercutir no cuidado, desenvolvimento, participação e acesso a direitos.	Insegurança alimentar; dificuldades relacionadas à moradia, renda ou transporte; barreiras de acesso à saúde, educação ou assistência social; dificuldades para acessar direitos ou benefícios quando aplicáveis.	Identificar necessidades e suas repercussões; orientar sobre serviços e direitos pertinentes; articular assistência social, educação e outros recursos da rede conforme a situação; acompanhar o acesso e a continuidade do cuidado.	Linha de Cuidado para Pessoas com TEA (MS, 2025); Linha de Cuidado para a Atenção às Pessoas com TEA e suas Famílias na RAPS (MS, 2015). Guia sobre a Estimulação Precoce na Atenção Básica (MS, 2016).

Aspecto observado	Faixa etária de referência	Exemplos de observação	Possíveis ações da APS	Referências MS úteis
Rede de apoio insuficiente	Ao longo do acompanhamento: identificar pessoas, serviços e recursos disponíveis para compartilhar cuidados, responsabilidades e apoio à criança e à família.	Responsabilidades concentradas em um cuidador; pouca participação de familiares ou outras pessoas de referência; dificuldade de acessar apoio comunitário ou serviços necessários.	Mapear rede formal e informal; identificar necessidades de apoio não atendidas; favorecer articulação com recursos do território e serviços da rede; fortalecer a coordenação entre saúde e demais setores envolvidos.	Linha de Cuidado para Pessoas com TEA (MS, 2025); Linha de Cuidado para a Atenção às Pessoas com TEA e suas Famílias na RAPS (MS, 2015). Guia sobre a Estimulação Precoce na Atenção Básica (MS, 2016); Desenvolvimento Neuropsicomotor, Sinais de Alerta e Estimulação Precoce (MS, 2023).

Referências

Documentos do Ministério da Saúde

Aponte a câmera do celular para o QR code para acessar o documento oficial na Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde.

BRASIL. Ministério da Saúde. Desenvolvimento neuropsicomotor, sinais de alerta e estimulação precoce: um guia para profissionais de saúde e educação. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2023.



ACESSO AO DOCUMENTO OFICIAL

Desenvolvimento Neuropsicomotor, Sinais de Alerta e Estimulação Precoce (2023)

Biblioteca Virtual em Saúde — Ministério da Saúde

BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes de atenção à reabilitação da pessoa com transtornos do espectro do autismo (TEA). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2014.



ACESSO AO DOCUMENTO OFICIAL

Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com TEA (2014)

Biblioteca Virtual em Saúde — Ministério da Saúde

BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes de estimulação precoce: crianças de zero a 3 anos com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2016.



ACESSO AO DOCUMENTO OFICIAL

Diretrizes de Estimulação Precoce (2016)

Biblioteca Virtual em Saúde — Ministério da Saúde

BRASIL. Ministério da Saúde. Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2019.

ACESSO AO DOCUMENTO OFICIAL

Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos (2019)

Biblioteca Virtual em Saúde — Ministério da Saúde

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Guia sobre a estimulação precoce na Atenção Básica: contribuições para abordagem do desenvolvimento neuropsicomotor pelas equipes de Atenção Básica, Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf), no contexto da microcefalia. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2016.

BRASIL. Ministério da Saúde. Linha de cuidado para a atenção às pessoas com transtornos do espectro do autismo e suas famílias na Rede de Atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2015.

ACESSO AO DOCUMENTO OFICIAL

Linha de Cuidado para Pessoas com TEA e suas Famílias na RAPS (2015)

Biblioteca Virtual em Saúde — Ministério da Saúde

BRASIL. Ministério da Saúde. Linha de cuidado para pessoas com transtorno do espectro autista – TEA. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025.

ACESSO AO DOCUMENTO OFICIAL

Linha de Cuidado para Pessoas com TEA (2025)

Biblioteca Virtual em Saúde — Ministério da Saúde

Literatura científica complementar utilizada na construção

BAL, V. H.; KIM, S. H.; CHEONG, D.; LORD, C. Daily living skills in individuals with autism spectrum disorder from 2 to 21 years of age. Autism, v. 19, n. 7, p. 774–784, 2015. DOI: 10.1177/1362361315575840.

BRADSHAW, J. et al. Early emergence of discrepancy in adaptive behavior and cognitive skills in toddlers with autism spectrum disorder. Autism, v. 23, n. 6, 2019. DOI: 10.1177/1362361318815662.

MATTHEWS, N. L. et al. Revisiting cognitive and adaptive functioning in children and adolescents with autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, v. 45, n. 1, p. 138–156, 2015. DOI: 10.1007/s10803-014-2200-0.

MILLER, M. et al. Response to name in infants developing autism spectrum disorder: a prospective study. The Journal of Pediatrics, v. 183, p. 141–146.e1, 2017. DOI: 10.1016/j.jpeds.2016.12.071.

NADIG, A. S. et al. A prospective study of response to name in infants at risk for autism. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, v. 161, n. 4, p. 378–383, 2007. DOI: 10.1001/archpedi.161.4.378.